



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ASI0729

Desarrollo de Aplicaciones Open Source

NRC

7737

Informe del Trabajo

Docente

Ivan Robles Fernández

Equipo

CodeBrokers

Proyecto

VitaLkink

Código - Apellidos y Nombres

codigo - integrante

U202312348 - Said Conde, Yazid

codigo - integrante

codigo - integrante

codigo - integrante

Período 202620

septiembre 2026

Registro de Versiones del Informe

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
AV1	8/31/2026	Yazid Said Conde	Desarrollo de description de description de la startup, antecedentes & problematica y segmento objetivo. (Capitulo I)

Student Outcome

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.		

Capítulo I: Introducción

1.1 Startup Profile

1.1.1 Descripción de la Startup

Como startup, tenemos el compromiso de contribuir al cuidado y bienestar de los adultos mayores. Por ello, desarrollamos VitaLink, una plataforma digital orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores, cuyo objetivo es conectar, dentro de un mismo ecosistema, a los adultos mayores, sus familiares y diferentes proveedores de servicios de salud.

VitaLink permite centralizar información relacionada con el estado del adulto mayor y generar alertas cuando se identifican valores o combinaciones de datos que podrían representar una situación de riesgo. Estas alertas pueden ser comunicadas a los familiares autorizados y, dependiendo de la situación, a una institución de salud registrada en la plataforma.

De esta manera, CodeBrokers busca desarrollar tecnología que no solo permita monitorear información, sino que también facilite una respuesta oportuna y coordinada ante posibles situaciones de riesgo, contribuyendo a mejorar el acompañamiento y la seguridad de los adultos mayores.

Misión

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida y la seguridad de los adultos mayores mediante VitaLink, proporcionando herramientas digitales de monitoreo preventivo que permitan detectar oportunamente posibles situaciones de riesgo, facilitar la comunicación con sus familiares y conectar de manera eficiente con proveedores de servicios de salud.

Buscamos utilizar la tecnología como una herramienta de prevención y acompañamiento, facilitando que las personas responsables del cuidado puedan contar con información oportuna para tomar decisiones y actuar ante posibles situaciones de riesgo.

Visión

Nuestra visión es convertir a VitaLink, en una startup referente en Latinoamérica en el desarrollo de soluciones digitales para el monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores.

Buscamos construir un ecosistema en el que adultos mayores, familiares, clínicas, hospitales y profesionales de la salud puedan mantenerse conectados, favoreciendo una atención más preventiva, rápida, accesible y centrada en la persona.

A largo plazo, VitaLink podrá evolucionar mediante la integración con dispositivos inteligentes y otras tecnologías aplicadas al cuidado de la salud, permitiendo obtener información de manera más continua y automatizada. De esta forma, aspiramos a contribuir a la transición de un modelo de cuidado principalmente reactivo hacia uno preventivo, conectado y basado en información, donde la tecnología permita anticiparse a posibles situaciones de riesgo y facilitar una atención oportuna.

1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo

Integrante 1: (Escribe aca)

Código de estudiante: (Escribe aca)

Carrera: (Escribe aca)

Descripción: (Escribe aca)

Aporte al equipo: (Escribe aca)



Integrante 1: (Escribe aca)
Código de estudiante: (Escribe aca)
Carrera: (Escribe aca)
Descripción: (Escribe aca)
Aporte al equipo: (Escribe aca)



Integrante 1: (Escribe aca)
Código de estudiante: (Escribe aca)
Carrera: (Escribe aca)
Descripción: (Escribe aca)
Aporte al equipo: (Escribe aca)



Integrante 1: (Escribe aca)
Código de estudiante: (Escribe aca)
Carrera: (Escribe aca)
Descripción: (Escribe aca)
Aporte al equipo: (Escribe aca)



Integrante 1: (Escribe aca)
Código de estudiante: (Escribe aca)
Carrera: (Escribe aca)
Descripción: (Escribe aca)
Aporte al equipo: (Escribe aca)



1.2 Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

Antecedentes

El envejecimiento de la población representa un desafío cada vez más importante para los sistemas de salud y las familias. La Organización Mundial de la Salud señala que la población mundial de 60 años o más está aumentando rápidamente y estima que para 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. Este proceso genera nuevos desafíos para los sistemas de salud y asistencia social, especialmente en la atención y cuidado de las personas mayores (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2025).

Frente a esta realidad surge **SeniorCare**, orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores. La plataforma busca centralizar información relevante, identificar posibles situaciones de riesgo y facilitar la comunicación entre el adulto mayor, sus familiares y proveedores de atención.

Problemática

Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran:

- **Falta de monitoreo continuo:** los familiares no siempre cuentan con información actualizada sobre el estado del adulto mayor.
- **Detección tardía de situaciones de riesgo:** determinados cambios en indicadores de salud pueden pasar desapercibidos hasta que la situación requiere atención.
- **Dificultad para reaccionar oportunamente ante incidentes:** ante una caída, alteración de signos vitales u otra situación de riesgo, puede existir un retraso en la comunicación con familiares o servicios de atención.
- **Información de salud dispersa:** los datos relacionados con el adulto mayor pueden encontrarse distribuidos entre familiares, documentos o diferentes proveedores de salud.
- **Falta de conexión entre familiares y proveedores de atención:** cuando ocurre una situación que requiere asistencia, no siempre existe un mecanismo centralizado que facilite el contacto con una institución o profesional disponible.
- **Dependencia de la supervisión presencial:** el acompañamiento puede depender de que un familiar o cuidador se encuentre físicamente cerca del adulto mayor.

Estas dificultades pueden generar preocupación en los familiares, retrasos en la atención y una mayor exposición del adulto mayor ante situaciones que podrían ser detectadas de manera temprana.

5W y 2H

What? (¿Cuál es el problema?)

Los familiares y cuidadores de adultos mayores no siempre cuentan con una herramienta que les permita conocer oportunamente el estado de salud de la persona a su cargo y detectar posibles situaciones de riesgo cuando no se encuentran físicamente con ella.

Actualmente, el seguimiento suele depender de llamadas telefónicas, mensajes, visitas presenciales o de que el propio adulto mayor comunique que presenta algún problema. Esto puede generar detección tardía de situaciones de riesgo, especialmente cuando el adulto mayor vive solo, permanece varias horas sin compañía o presenta dificultades para comunicar oportunamente un cambio en su estado.

Además, la información relacionada con su salud puede encontrarse dispersa entre familiares, documentos o diferentes proveedores de atención, dificultando el seguimiento y la toma de decisiones.

When? (¿Cuándo sucede el problema?)

El problema puede presentarse de manera recurrente durante las actividades cotidianas del adulto mayor, especialmente cuando los familiares o cuidadores no se encuentran cerca para supervisarlo.

La situación se vuelve más crítica cuando ocurre un evento inesperado, como una caída, una alteración de determinados indicadores de salud o cualquier otra condición que pueda representar un riesgo. En estos casos, el tiempo transcurrido entre la aparición del problema y la comunicación con un familiar o proveedor de atención puede ser determinante.

También se presenta cuando los familiares desean conocer el estado del adulto mayor, pero no cuentan con información actualizada y deben depender de una comunicación manual para obtenerla.

Where? (¿Dónde ocurre el problema?)

El problema se presenta principalmente en hogares y entornos donde los adultos mayores desarrollan sus actividades cotidianas, especialmente cuando permanecen solos o tienen un nivel reducido de supervisión presencial.

En el contexto inicial de VitaLink, la problemática se plantea principalmente en **Lima Metropolitana** y otras ciudades del Perú, donde existe una creciente población adulta mayor y una necesidad de fortalecer los mecanismos de acompañamiento y prevención.

Asimismo, el problema involucra la relación entre los hogares de los adultos mayores y los establecimientos y profesionales de salud, debido a la dificultad de conectar oportunamente a ambas partes cuando se presenta una situación que requiere atención.

Why? (¿Por qué ocurre el problema?)

El problema ocurre principalmente porque el acompañamiento de los adultos mayores continúa dependiendo, en gran medida, de la supervisión presencial y de mecanismos de comunicación manuales.

A pesar de la disponibilidad de tecnologías de monitoreo y dispositivos inteligentes, no siempre existe una plataforma accesible que integre la información del adulto mayor con un sistema de alertas y una red de familiares y proveedores de atención.

Además, la información puede encontrarse fragmentada y no necesariamente existe un mecanismo que permita detectar una posible situación de riesgo, notificarla a las personas responsables y facilitar el acceso a atención desde un mismo ecosistema.

Esta situación dificulta pasar de un modelo de atención principalmente reactivo a uno más preventivo y basado en información.

Who? (¿Quiénes están involucrados?)

- **Adultos mayores:** quienes son los principales beneficiarios de una solución que permita brindarles mayor seguridad y acompañamiento durante sus actividades cotidianas.
- **Familiares y cuidadores:** quienes tienen la responsabilidad de acompañar y supervisar al adulto mayor, pero pueden tener dificultades para hacerlo de manera permanente debido a sus actividades laborales, distancia geográfica u otras responsabilidades.
- **Clínicas y hospitales:** que pueden participar como proveedores de atención asociados al adulto mayor y recibir alertas cuando sea necesario gestionar una atención.

How? (¿Cómo se presenta el problema?)

El proceso actual puede desarrollarse de la siguiente manera:

Adulto mayor presenta una situación de riesgo → no existe monitoreo o alerta automática → el familiar desconoce la situación → el problema continúa o se agrava → el adulto mayor o una tercera persona comunica el incidente → el familiar intenta determinar qué hacer → busca contactar a un establecimiento o profesional de salud → se inicia la gestión de atención.

Este proceso puede generar retrasos en la comunicación y en la respuesta, especialmente cuando el familiar se encuentra lejos o desconoce la gravedad de la situación.

En otros casos, el familiar puede realizar llamadas o comunicarse constantemente con el adulto mayor para verificar que se encuentre bien, lo que genera una dependencia de la supervisión manual.

How much? (¿Qué tan severo es el problema?)

La severidad del problema no se limita a un costo económico directo, sino que está relacionada principalmente con el tiempo de respuesta, la seguridad del adulto mayor y la tranquilidad de sus familiares.

Por ello, el impacto del problema puede observarse en tres dimensiones principales:

- **Seguridad:** una situación de riesgo podría no ser detectada oportunamente.
- **Tiempo:** puede existir un retraso entre la aparición del problema y la comunicación con familiares o proveedores de atención.
- **Tranquilidad familiar:** los familiares no cuentan siempre con información suficiente para saber si el adulto mayor se encuentra bien.

1.2.2 Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements El estado actual del telemonitoreo y cuidado de adultos mayores se ha centrado principalmente en cuidadores familiares que gestionan registros manuales y en centros de salud que atienden emergencias de manera reactiva, generando demoras críticas y una atención fragmentada ante complicaciones de salud.

Lo que los productos y servicios existentes no logran resolver es la falta de integración en tiempo real entre el monitoreo continuo de signos vitales y la capacidad de agendar consultas médicas de forma inmediata.

Nuestra plataforma resuelve esta brecha mediante un servicio SaaS que procesa telemetría biométrica en tiempo real, evalúa anomalías y pre-agenda de forma automática citas preventivas o prioritarias con centros de salud asociados, derivando reportes de evolución al instante tanto al cuidador como al especialista.

El enfoque inicial estará dirigido a cuidadores familiares a cargo de adultos mayores y a centros de salud locales o clínicas ambulatorias.

Sabremos que tenemos éxito cuando se logre una reducción del 50% en el tiempo necesario para coordinar una cita ante una anomalía, una tasa mínima del 70% de aceptación en las citas pre-agendadas y la afiliación activa de al menos 15 centros de salud a la red.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions Business Outcomes

1. *Creemos que nuestros clientes necesitan* una forma confiable, centralizada y en tiempo real de monitorear la salud de los adultos mayores para prevenir complicaciones médicas y actuar con rapidez ante emergencias.
2. *Estas necesidades se pueden resolver con* una plataforma web SaaS integrada a telemetría IoT simulada que procesa signos vitales y un sistema inteligente de pre-agendamiento asistido para derivación clínica inmediata.
3. *Mis clientes iniciales serán* cuidadores familiares a cargo de adultos mayores con patologías crónicas y centros de salud o clínicas de atención ambulatoria.
4. *El valor #1 que un cliente quiere es* la tranquilidad de detectar anomalías a tiempo y asegurar una atención médica rápida y efectiva sin esperas burocráticas.

5. *Beneficios adicionales* consolidacion de la historia clinica en la nube, alertas criticas multicanal, reduccion del estres del cuidador y acceso a consultas a tarifa social para pacientes sin seguro medico.
6. *Voy a adquirir clientes a traves de* convenios directos con policlinicos locales, alianzas estrategicas con organizaciones no gubernamentales comunitarias, campanas digitales orientadas a familias y programas de recomendacion.
7. *Mi competencia es* servicios tradicionales de cuidadores particulares a domicilio, aplicaciones basicas de recordatorio de medicinas y plataformas genericas de reserva de citas medicas.
8. *Hare dinero a traves de* planes de suscripcion mensual por niveles (B2C) para familias y membresias o comisiones por citas efectivas (B2B) cobradas a centros medicos aliados.
9. *Los venceremos porque* integramos el sensado continuo de parametros vitales con un actuador inteligente que pre-agenda citas y alerta al instante, evitando que el usuario deba buscar especialistas por su cuenta en momentos de crisis.
10. *Mayor riesgo de producto* desconfianza de los usuarios en la precision del sistema de alertas o dificultades en la adopcion de la plataforma web por parte de personas de edad avanzada o cuidadores con baja alfabetizacion digital.
11. *Lo resolveremos con* disenio centrado en accesibilidad (a11y), interfaces de alto contraste, flujos asistidos de un solo clic, soporte guiado y videos explicativos breves durante el onboarding.
12. *Otra suposicion critica* los centros de salud asociados mantendran actualizada su disponibilidad de cupos en el sistema y los cuidadores validaran activamente las citas sugeridas por el actuador ante alertas criticas.

User Outcomes

- **Quien es el Usuario?**

Cuidadores principales (familiares directos o tutores) responsables del bienestar diario de adultos mayores, y personal de recepcion o profesionales medicos pertenecientes a las clinicas y centros de salud afiliados.

- **Que problemas tiene nuestro producto que debe resolver?**

La falta de control continuo sobre las variables fisiologicas del adulto mayor, la demora en la deteccion de sintomas de riesgo y los tramites engorrosos o demoras prolongadas para conseguir una consulta medica oportuna.

- **Que caracteristicas son importantes?**

Panel de control de telemetria en tiempo real (IoT simulada), notificaciones de emergencia inmediatas, pre-agendamiento automatizado de citas medicas segun cercania y disponibilidad, ficha de triaje clinico exportable y canal de consultas a costo social.

- **Donde encaja nuestro producto en su vida?**

En el acompanamiento preventivo cotidiano en el hogar y como canal prioritario de comunicacion entre la familia y la red medica ante cualquier alteracion de salud.

- **Cuando y como es usado?**

Funciona de manera continua en segundo plano procesando lecturas biometricas; el cuidador lo consulta diariamente para verificar historiales y de manera reactiva inmediata cuando recibe una notificacion de riesgo para confirmar una cita medica en un clic.

- **Como debe verse y comportarse el producto?**

Debe ser visualmente limpio, directo, predecible y con apego estricto a estandares de accesibilidad web: tipografia grande y legible, contrastes definidos, estados de alerta claros mediante codigo de colores y navegacion sin pasos superfluos.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- **Declaracion de Hipotesis 1**
 - **Creemos que lograremos** un incremento del 30% en la retencion mensual de la plataforma
 - **Si** los cuidadores familiares principales
 - **Obtienen** tranquilidad continua respecto a los signos vitales diarios y la estabilidad de salud de sus familiares de la tercera edad
 - **Con** un panel interactivo en tiempo real que visualiza metricas de telemetria IoT simulada (frecuencia cardiaca, SpO2 y deteccion de caidas).
- **Declaracion de Hipotesis 2**
 - **Creemos que lograremos** una reduccion del 50% en el tiempo promedio requerido para coordinar una consulta medica de urgencia
 - **Si** los cuidadores familiares
 - **Obtienen** el agendamiento inmediato de citas medicas sin necesidad de buscar o contactar manualmente a multiples proveedores de salud
 - **Con** una funcionalidad de auto-agendamiento inteligente que sugiere y reserva cupos optimos en centros medicos afiliados cercanos.
- **Declaracion de Hipotesis 3**
 - **Creemos que lograremos** un crecimiento del 40% en convenios con clinicas afiliadas y expansion de la red de salud
 - **Si** los proveedores de salud y el personal de recepcion clinica
 - **Obtienen** admisiones de pacientes pre-triados y acceso instantaneo al historial biometrico cronologico antes de la llegada del paciente
 - **Con** un modulo centralizado de historial de salud del paciente y exportacion de triaje.
- **Declaracion de Hipotesis 4**
 - **Creemos que lograremos** una tasa de confirmacion del 75% en alertas de emergencia dentro de los primeros 5 minutos
 - **Si** los tutores familiares designados
 - **Obtienen** conocimiento inmediato de umbrales fisiologicos fuera de rango o incidentes criticos detectados
 - **Con** una integracion de notificaciones externas automatizadas mediante SMS y servicios de mensajeria de emergencia.
- **Declaracion de Hipotesis 5**
 - **Creemos que lograremos** una tasa de adopcion del 35% en hogares de bajos recursos sin cobertura de seguro medico privado
 - **Si** los adultos mayores sin seguro y sus cuidadores
 - **Obtienen** acceso a consultas preventivas a bajo costo y derivacion directa hacia redes comunitarias de salud
 - **Con** un modulo integrado de atencion a tarifa social coordinado junto a organizaciones comunitarias de salud.
 - **We believe we will achieve** a 35% adoption rate among low-income households without private healthcare coverage
 - **If** uninsured elderly patients and their caregivers
 - **Attain** access to low-cost preventive consultations and direct referral to community health networks
 - **With** an integrated social-rate care module coordinated alongside verified community healthcare organizations.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1. Business Problem	2. Business Outcomes	3. Users
El cuidado de adultos mayores depende de registros manuales y respuestas reactivas ante emergencias de salud, generando demoras criticas y desconexion entre el monitoreo diario del hogar y los centros de atencion medica.	- Reduccion del 50% en el tiempo para coordinar una cita ante anomalias.- Tasa minima del 70% de aceptacion en citas pre-agendadas.- Afiliacion de al menos 15 centros de salud a la red.- Incremento del 30% en la retencion mensual de familias suscriptoras.	- Cuidadores familiares principales (hijos, tutores).- Adultos mayores con enfermedades cronicas.- Centros de salud y profesionales medicos independientes.
4. User Outcomes & Benefits	5. Solutions	6. Hypotheses
- Deteccion temprana de anomalias biometricas y tranquilidad familiar continua.- Atencion medica rapida sin busqueda manual de proveedores en crisis.- Historial clinico y triaje previo disponible para el medico antes de la consulta.- Acceso a consultas a tarifa social para adultos mayores sin seguro.	- Plataforma SaaS con tablero de telemetria IoT simulada en tiempo real.- Sistema inteligente de triaje y pre-agendamiento automatico de consultas.- Historial biometrico centralizado y ficha de triaje exportable.- Modulo de atencion a tarifa social conectado con policlinicos y ONGs.- Notificaciones automatizadas via SMS y mensajeria de emergencia.	- Creemos que el monitoreo IoT en tiempo real lograra un 30% mas de retencion mensual al brindar tranquilidad continua a los cuidadores.- Creemos que el auto-agendamiento inteligente reducira en 50% el tiempo de coordinacion de citas de urgencia.- Creemos que el historial y triaje previo aumentara un 40% los convenios con clinicas.- Creemos que las alertas SMS lograran un 75% de confirmacion en los primeros 5 minutos.- Creemos que la tarifa social lograra un 35% de adopcion en hogares sin seguro privado.
7. What is the most important thing we need to learn first?	8. What is the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?	
- Validar si los cuidadores familiares aceptan y confian en el auto-agendamiento ante una anomalia detectada.- Confirmar la disposicion de las clinicas para publicar y gestionar sus cupos de atencion dentro del SaaS.- Identificar el rango de precio mensual aceptable para los planes familiares de suscripcion.	- Desplegar la Landing Page con la propuesta de valor y medir el interes de registro de cuidadores y clinicas.- Probar prototipos interactivos en Figma con cuidadores para validar el flujo de confirmacion de citas en un clic.- Ejecutar simulaciones del flujo de datos IoT y pre-agendamiento en el MVP inicial.	

1.3 Segmentos objetivo

1. Adultos mayores y sus familias que requieren acompañamiento preventivo

Este segmento está conformado por adultos mayores de 60 años y sus familiares, especialmente aquellos que desean mantener un sistema de acompañamiento y monitoreo preventivo para mejorar la seguridad del adulto mayor.

A diferencia del primer segmento, este grupo puede estar compuesto por familias en las que el propio adulto mayor participa activamente en la decisión de utilizar VitaLink, por ejemplo, porque vive solo, pasa gran parte del día sin compañía o desea que sus familiares puedan conocer su estado sin necesidad de realizar llamadas constantes.

Características principales:

- **Adultos mayores de 60 años a más.**
 - **Pueden vivir solos, con familiares o con un cuidador.**
 - **Cuentan con uno o más familiares interesados en su bienestar.**
 - **Buscan mantener cierto nivel de independencia sin dejar de contar con acompañamiento.**
 - **Pueden estar asociados a una clínica, hospital o profesional de salud.**
 - **Tanto el adulto mayor como sus familiares pueden interactuar con la plataforma.**
-

2. Clínicas y hospitales

Este segmento representa a los proveedores de atención que forman parte del ecosistema de VitaLink.

Perfil:

- **Clínicas y hospitales privados.**
- **Centros de atención interesados en servicios digitales.**
- **Médicos independientes.**
- **Profesionales que ofrecen atención a domicilio.**

Necesidad: Recibir solicitudes de atención de potenciales pacientes y contar con un canal digital para gestionar dichas solicitudes.

Qué les ofrece VitaLink:

- **Acceso a potenciales pacientes.**
- **Recepción de alertas o solicitudes de atención.**
- **Mayor visibilidad de las necesidades de los usuarios.**
- **Gestión de solicitudes desde la plataforma.**
- **Posibilidad de ampliar sus servicios mediante atención conectada digitalmente.**

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

2.2.2. Registro de entrevistas

2.2.3. Análisis de entrevistas

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

2.3.2. User Task Matrix

2.3.3. User Journey Mapping

2.3.4. Empathy Mapping

2.4. Big Picture Event Storming

2.5. Ubiquitous Language

3. Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

3.2. Impact Mapping

3.3. Product Backlog.

4. Capítulo IV: Product Design

El diseño visual de la aplicación VitaLink sigue una estética entre lo clínico y lo confiable, esto porque va relacionado a la identidad que tiene el startup BrokerCodes y el compromiso que tenemos por ofrecer soluciones de calidad hacia el sector salud, enfocadas en el cuidado y acompañamiento de adultos mayores.

Es por esto que, en este capítulo, describiremos cada uno de los detalles y estilos que estaremos utilizando al momento de desarrollar la aplicación (siguiendo los principios UX y UI).

4.1. Style Guidelines

Branding

El logo principal representa a Vitalink, una plataforma orientada al monitoreo y seguimiento de la salud de los adultos mayores. El nombre surge de la combinación de “Vital”, relacionado con los signos vitales, la salud y el bienestar, y “Link”, que representa la conexión constante entre el adulto mayor, sus familiares y los profesionales o centros de salud.

La identidad visual incorpora un ícono minimalista que combina elementos relacionados con la salud, el monitoreo y la conexión. El símbolo representa una figura humana protegida dentro de una forma inspirada en un corazón, integrando además una línea de pulso o electrocardiograma. Este recurso visual comunica

de manera directa el propósito de Vitalink: cuidar, monitorear y mantener conectadas a las personas involucradas en el bienestar del adulto mayor.



Typography

La tipografía principal empleada será Arial, utilizando sus variantes Regular, SemiBold y Bold.

La elección de esta tipografía se debe principalmente a su alta legibilidad, simplicidad y compatibilidad con diferentes dispositivos tecnológicos, como ordenadores, tabletas y teléfonos móviles. Esto resulta especialmente importante para Vitalink, ya que la plataforma puede ser utilizada por adultos mayores, familiares y profesionales de la salud.

El uso de una tipografía clara y fácil de leer permitirá que la información relacionada con signos vitales, alertas, estados de salud y otros datos importantes pueda ser comprendida rápidamente.

El tamaño de letra utilizado en la aplicación seguirá la siguiente distribución:

Títulos principales: 2.25rem (36px), utilizados para encabezados principales y secciones importantes. Subtítulos: entre 1.5rem (24px) y 1.75rem (28px), utilizados para organizar las diferentes secciones de información. Texto secundario: entre 1.125rem (18px) y 1.25rem (20px), especialmente recomendado para información relevante o elementos que requieran mayor visibilidad. Cuerpo del texto: 1rem (16px), acompañado de un interlineado aproximado de 1.5 a 1.6 para facilitar la lectura. Información auxiliar: 0.875rem (14px), utilizada para etiquetas, fechas, información complementaria o textos secundarios.

La tipografía y los colores serán utilizados manteniendo un contraste adecuado entre el texto y el fondo, buscando cumplir con un ratio mínimo de 4.5:1, de acuerdo con las recomendaciones de accesibilidad WCAG 2.1 AA.

Paleta de Colores y Jerarquía Visual

1. Paleta Principal

- **Verde Vitalink (#1D9E75):** Funciona como color principal de la marca y se utiliza en botones, elementos interactivos, indicadores y componentes destacados.

2. Paleta Secundaria

- **Verde Oscuro (#0F6E56):** Se utiliza como color complementario para reforzar elementos de la interfaz y generar diferentes niveles de jerarquía visual.

- **Neutro Claro (#F8F8F8):** Funciona como base para fondos y superficies, permitiendo mantener una interfaz limpia y facilitar la lectura del contenido.

3. Colores Funcionales

- **Tonos verdes:** Se utilizan principalmente para representar estados positivos, información correcta, bienestar y confirmaciones dentro de la aplicación. Estos colores permiten comunicar visualmente información relevante sin sobrecargar la interfaz.

4. Neutrales

- **Tonos neutros:** Se utilizan para fondos, tarjetas, separadores y elementos secundarios, creando contraste con los colores principales y manteniendo una apariencia limpia y profesional.

	GAMA DE 7 TONOS POR CATEGORÍA DE COLOR						
	Tono 1	Tono 2	Tono 3	Tono 4	Tono 5	Tono 6	Tono 7
Primary: Verde Vitalink (#1D9E75)	#E8F7F2	#ADF0DB	#71E5C0	#30D9A3	#1D9E75	#146C50	#10372B
Secondary: Azul Profundo (#042C53)	#E6F0F9	#A3CFFB	#5EACF7	#1586F4	#0962B9	#06407A	#0C2C4B
Tertiary: Verde Oscuro (#0F6E56)	#E8F8F4	#AAF3E1	#6BEBCA	#28E2B3	#17AB85	#0F6E56	#0E392E
Neutral: Blanco Neutro (#F8F8F8)	#FFFFFF	#F8F8F8	#E2ECF1	#B8CDDA	#84A4B5	#517282	#22323A

4.1.1. General Style Guidelines

4.1.2. Web Style Guidelines

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems

4.2.2. Labeling Systems

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

4.2.4. Searching Systems

4.2.5. Navigation Systems

4.3. Landing Page UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe

4.3.2. Landing Page Mock-up

4.4 Web Applications UX/UI Design

4.4.1. Web Applications Wireframes

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

4.4.3 .Web Applications Mock-ups

4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

4.5. Web Applications Prototyping

4.6. Domain-Driven Software Architecture

4.6.1. Design-Level Event Storming

4.6.2. Software Architecture Context Diagram

4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

4.6.4. Software Architecture Component Diagrams

4.7. Software Object-Oriented Design*

4.7.1. Class Diagrams

4.8. Database Design

4.8.1. Database Diagrams

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

5.1.1. Software Development Environment Configuration

5.1.2. Source Code Management

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

5.1.4. Software Deployment Configuration

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.3. Sprint 3

5.2.3.1. Sprint Planning 3

5.2.3.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.3.3. Sprint Backlog 3

5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.3.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.4. Sprint 4

5.2.4.1. Sprint Planning 4

5.2.4.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.4.3. Sprint Backlog 4

5.2.4.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.4.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.4.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.4.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.4.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.3. Validation Interviews.

5.3.1. Diseño de Entrevistas.

5.3.2. Registro de Entrevistas.

5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.

5.4. Video About the product

6. Conclusiones

6.1 Conclusiones y recomendaciones

6.2. Video about the team

7. Bibliografia

8. Anexos